ONEMA-POP-041 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-041 — Gerenciamento Ético de Recusa, Desacato,
Assédio e Ruptura da Relação Assistencial

1. Identificação institucional

técnica

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a atuação de enfermagem em: Gerenciamento Ético de Recusa, Desacato, Assédio e Ruptura da Relação Assistencial. Aplicável a visitas e/ou triagem digital conforme pertinência, sem substituir serviço de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, treinado e autorizado; Conflitos, recusa de cuidado, assédio ou quebra da relação terapêutica; respeitar autonomia e não abandonar paciente em risco. Não realizar intervenções além da competência, prescrição ou recursos disponíveis.

4. Materiais e equipamentos; fornecimento

Enfermeiro: identificação profissional, canal institucional seguro e registro; paciente: informações sobre opções de cuidado. Equipamentos de avaliação clínica de uso profissional são providos pelo enfermeiro; consumíveis do paciente conforme contratação.

5. Avaliação clínica e preparação

Verificar capacidade decisória aparente, compreensão, risco clínico imediato, barreiras de comunicação, coerção e existência de responsável legal. Confirmar identificação, consentimento, privacidade e localização para eventual emergência.

6. Execução técnica individualizada

1. Identificar-se e explicar procedimento, riscos, benefícios e alternativas em linguagem acessível.

2. Ouvir a recusa sem ameaça, punição, pressão comercial ou julgamento.

3. Confirmar compreensão solicitando que a pessoa explique sua decisão e suas consequências.

4. Avaliar sinais de emergência ou incapacidade de decisão; se presentes, acionar rede de urgência e RT.

5. Oferecer alternativas proporcionais, segunda avaliação ou reagendamento quando clinicamente seguro.

6. Em assédio/ameaça, interromper exposição do profissional, preservar segurança e comunicar coordenação; não

retaliar.

7. Formalizar recusa informada ou impossibilidade de coleta, testemunhas quando cabível e plano de continuidade.

8. Encerrar contato apenas após comunicar orientações e rota segura de continuidade; registrar intercorrência

institucional.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Ameaça física, violência, coação, risco de morte ou incapacidade decisória: priorizar proteção e emergência; não abandonar paciente vulnerável.

8. Cuidados posteriores e orientações

Fornecer orientações escritas, sinais de alerta e canais institucionais; preservar privacidade.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Registrar identificação, data/hora, modalidade, consentimento, queixa, avaliação, achados positivos/negativos, etapas realizadas, intervenções não realizadas e justificativa, comunicação com RT/rede, encaminhamento, orientações, plano de retorno e assinatura do enfermeiro.

10. Referências específicas e rastreáveis

 COFEN — Resolução 736/2024, Processo de Enfermagem — https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/

 COFEN — Código de Ética, Resolução 564/2017 — https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017/

Referências consultadas como suporte temático; a correspondência exaustiva entre cada passo e a evidência, bem como regras locais e manuais dos fabricantes, requer análise pelo RT.